2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

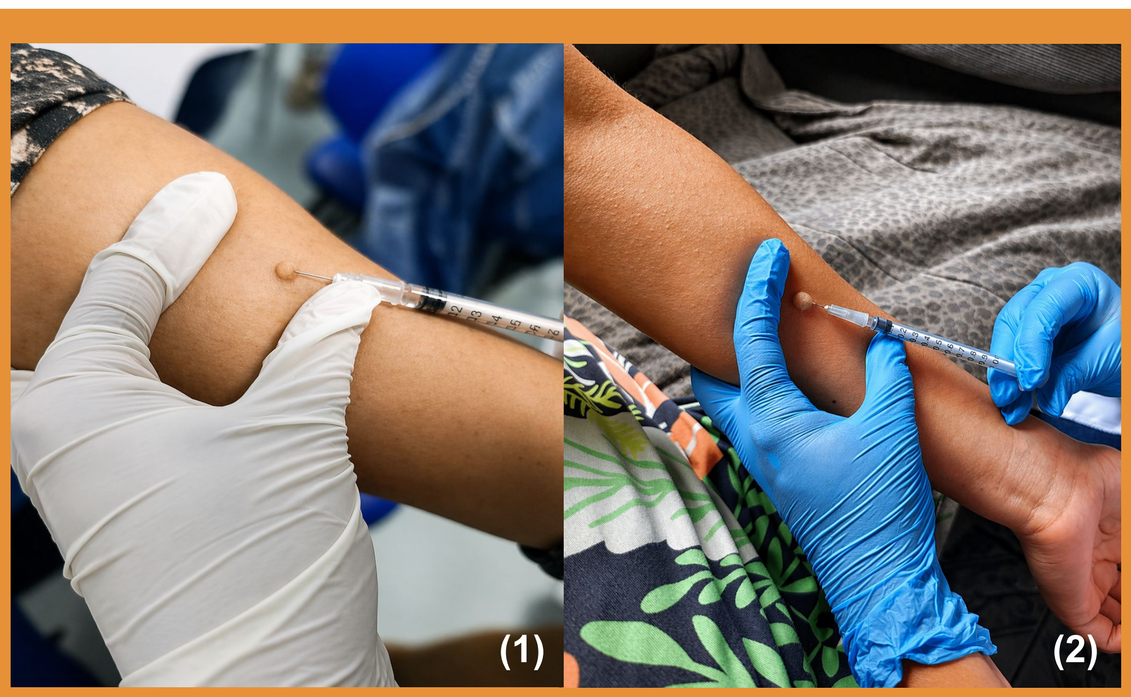
Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Organização do processo de trabalho para ampliação da oferta de PPD em uma Unidade de Atenção Primária: Relato de Experiência

Daiane Barbosa da Silva[1]; Daniela Linhares Pinto[2]; Jully Steffany da Silva[2]; Regina Helena de Souza[3]

[1]Preceptora do Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade (SMS-Rio).
[2]Residente de Enfermagem de Família e Comunidade (SMS-Rio).
[3]Enfermeira Responsável Técnica de Enfermagem



Fonte: Arquivo pessoal dos autores, 2025-2026.
(1)Treinamento Profissional para aplicação e leitura de PPD.
(2)Aplicação de PPD em Visita Domiciliar.

O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO LATENTE POR TUBERCULOSE (ILTB) É OPORTUNIZADO CONSIDERANDO TRÊS ETAPAS FUNDAMENTAIS:

- **Treinamento Profissional Teórico-Prático**
- **Organização das agendas**
- **Flexibilização do Acesso**

Introdução

A infecção latente da tuberculose (ILTB) caracteriza-se pela presença do *Mycobacterium tuberculosis* no organismo sem manifestações clínicas ativas, não havendo transmissão da doença, mas com risco de progressão para a forma ativa, especialmente em indivíduos vulneráveis. A prova tuberculínica é um dos principais métodos utilizados para identificar essa condição sendo realizada através da aplicação de Derivado Proteico Purificado (PPD) e avaliação da resposta imunobiológica.

Objetivos

O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de enfermeiros preceptores e residentes em Saúde da Família e Comunidade na reorganização do processo de trabalho para ampliação do acesso ao exame de Prova Tuberculínica em uma unidade de Atenção Primária à Saúde.

Métodos

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido em uma Clínica da Família localizada em uma comunidade da zona norte do município do Rio de Janeiro, território carcaterizado por diferentes vulnerabilidades sociais, como baixo IDH, precariedade de saneamento básico e dificuldades de acesso a serviços essenciais. Nesse contexto, evidencia-se a elevada incidência de tuberculose pulmonar no território, com ocorrência frequente de adoecimento entre múltiplos membros de uma mesma família, o que sugere transmissão intradomiciliar ativa e possíveis fragilidades nas ações de vigilância e controle. A partir desse diagnóstico situacional, a equipe de enfermagem reconheceu a necessidade de qualificar e ampliar, de forma sistemática e oportuna, a avaliação dos contatos de casos confirmados, fortalecendo estratégias de busca ativa, rastreamento e acompanhamento, com vistas à interrupção da cadeia de transmissão e à redução de casos de tuberculose na comunidade.

Resultados

A reorganização do processo de trabalho ocorreu em três etapas: treinamento teórico-prático dos enfermeiros para aplicação e leitura da prova tuberculínica; criação de agenda para atendimento; e flexibilização do acesso, permitindo a realização do teste por agendamento, demanda espontânea e em visitas domiciliares para indivíduos em maior vulnerabilidade.

Fonte: Elabora pelos autores, 2026. Editado com recursos de Inteligência Artificial IA (ChatGPT).

Conclusão/Considerações finais

A experiência demonstrou que a reorganização do processo de trabalho, aliada à ampliação da autonomia da enfermagem, potencializa as ações de vigilância e controle da tuberculose no território. Esse movimento favorece maior resolutividade das práticas assistenciais, qualifica o acompanhamento dos casos e amplia o acesso oportuno ao diagnóstico da infecção latente.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SMS-RIO)
DAIANE BARBOSA DA SILVA
Enfermeira Preceptora

E-mail: prefc.smsrio@gmail.com
Contatos: e-mail
Website: https://sigaenf.subpav.org/

Saúde Pública Carioca | Rio Prefeitura SUS
PREFC Programa de Residência em Enfermagem de Família e Comunidade